Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Saignement ou INR élevé sous anticoagulant

Adulte · AVK : selon l'INR · AOD et HBPM : selon la clinique

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · hémorragie abondante, menaçante ou non contrôlée ; malaise, PAS < 100 mmHg, pouls > 120/min ; méléna, hématémèse ; **traumatisme crânien** sous anticoagulant ; céphalée brutale, déficit.

J'applique si

- **AVK** (fluindione, warfarine, acénocoumarol) : **INR au-dessus de la cible**, avec ou sans saignement.
- **AOD** (apixaban, rivaroxaban, dabigatran, édoxaban) ou HBPM : saignement, chute, traumatisme.

Je n'applique pas → avis médical

- **AOD, HBPM** : ni INR ni vitamine K (sans effet) ; avis selon la clinique.
- **Vitamine K** sans prescription ; allergie à l'arachide ou au soja.
- Enfant : hors protocole.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. Saignement : **compression directe**, ferme, sans relâcher ; prise suivante **suspendue**.
2. Gravité : PA, FC, pâleur ; localisation (tête, œil, digestif, hématome profond).
3. Molécule, dose, **heure de la dernière prise**, INR cible et dernier INR ; antiagrégant, AINS, interaction.

SUR CE PROTOCOLE

4. AVK, sans saignement grave : conduite **selon l'INR** (carte ci-contre).
5. **INR de contrôle le lendemain** (prescription IDE) ; si toujours élevé, même conduite.
6. INR demandé non revenu le soir : ne pas donner l'AVK, sauf consigne médicale.

SUR AVIS MÉDICAL

7. **Vitamine K1** per os (10 mg/1 mL) : 1–2 mg si INR 6–10, 5 mg si ≥ 10 (HAS) ; reprise ; lieu de surveillance.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

AVK, INR cible 2–3

< 4 → poursuivre

4 à < 6 → sauter **une** prise

6 à < 10 → **arrêter**, avis le jour même

≥ 10 → **arrêter**, avis **sans délai**

- Cible ≥ 3 (valve mécanique) : < 6 pas de saut ; ≥ 6 avis spécialisé le jour même

J'appelle le médecin

- **Le jour même** : tout INR ≥ 4 ; saignement mineur contrôlé (gencives, hématome, hématurie).
- **Sans délai** : INR ≥ 10, saignement qui récidive.

Je surveille et je trace

- Saignement, PA, FC, conscience ; après une chute : protocole « Surveillance traumatisme crânien ».
- INR, prise sautée ou arrêtée, vitamine K (dose, heure), avis ; INR le lendemain.

À retenir : AVK : on agit sur l'INR ; AOD : sur la clinique seule. Vitamine K seulement sur prescription.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS/GEHT, Prise en charge des surdosages en AVK, des situations à risque et des accidents hémorragiques (04/2008) ; RCP Vitamine K1 Cheplapharm 10 mg/1 mL (ANSM, MAJ 22/04/2025) ; ARS IDF/SGGIF fiche 9 (2016) ; OMéDIT CVL, dotations (02/2025) ; arrêté « prescriptions » du 26/06/2026 (VI) ; art. R4311-6 2° CSP.

Réf. DOTR-IDE-ANTICO | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature